MAPA DE CONSULTA RÁPIDA · PLANTÃO

Ventilador Mecânico Pós-Intubação

Preparo, montagem e parâmetros seguros de urgência

Fonte de Oxigênio — PRÉ-REQUISITO

- Usar válvula redutora de pressão de O2 — não o fluxômetro (não gera pressão suficiente).
- Sem válvula: ligar direto na rede é aceitável só em urgência, nunca o ideal (risco de danificar a célula de O2).
- Regular a válvula entre 3 e 4 kgf/cm² de pressão.
- Ventilador sempre na tomada — aparelhos antigos não sustentam só na bateria.

Alarmes e Atenção — ALERTA

- Pressão de O2: abaixo de 3 kgf/cm² alarma **baixa**; acima de 5 kgf/cm² alarma **alta**.
- Alarme **vermelho**: crítico, contínuo até resolver a causa.
- Alarme **amarelo**: já ocorreu, mostra o motivo, não está soando agora.
- Alarme **verde**: sem alarme.

Fluxo de Preparo — ALGORITMO PRINCIPAL

1. Conectar a válvula ao ventilador e à rede de O2; abrir a rede.
2. Regular a válvula entre 3 e 4 kgf/cm² de pressão.
3. Ligar o ventilador na tomada e no botão protegido (geralmente atrás).
4. Autoteste/verificação do circuito.
5. Montar o circuito: 2 traqueias + Y + filtro HEPA (expiratório) + HMEF (proximal ao paciente).
6. Selecionar o modo (PCV/BIPAP) e configurar os parâmetros de urgência.
7. Sair do standby e conectar o paciente — a ventilação começa.
8. Monitorar alarmes e manter até alguém ajustar a ventilação conforme a necessidade real.

Parâmetros de Urgência — METAS · PCV/BIPAP

- Pressão inspiratória: 15 cmH_2O.
- Tempo inspiratório: 1 segundo.
- Frequência: 15/min.
- PEEP: 5 cmH_2O · FiO2: 100%.

Técnica e Nomenclatura — CLÍNICO

- Dräger renomeia os modos: IPPV = VCV, BIPAP = PCV, CPAP/ASB = PSV (mesma lógica, nomes próprios).
- PCV/VCV logo após a intubação; PSV na fase de desmame, quando o paciente respira sozinho.
- Puff: pela via do trach care (aspiração fechada), sincronizado com a inspiração do paciente.
- Aspiração: botão de O2 a 100% eleva a FiO2 por ~2 min e retorna sozinho ao valor programado.
- **Em urgência, priorizar parâmetros seguros e ganhar tempo até o ajuste correto.**

Nunca Faça — PROIBIÇÕES

- Nunca trocar a posição dos filtros: HMEF na saída expiratória danifica a válvula; HEPA junto ao paciente não aquece nem umidifica.
- Nunca nebulizar pelo fluxômetro — sempre pelo conector do ventilador, sincronizado com a inspiração.
- Nunca disparar o puff durante a expiração — a medicação não chega ao paciente.
- Nunca deixar o circuito sem o filtro HMEF reconectado após a nebulização.

Material de apoio para consulta rápida durante o plantão · baseado na aula sobre ventilação mecânica

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos